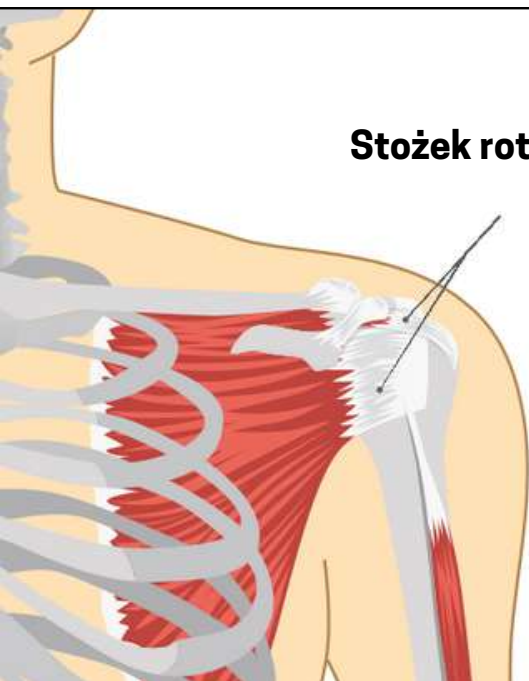




URAZY STOŻKA ROTATORÓW

Urazy stożka rotatorów mogą być spowodowane nagłym incydem traumatycznym lub rozwijać się z czasem. Objawy mogą obejmować ból, osłabienie i poczucie niestabilności lub niepokoju, wokół twojego ramienia.

Stożek rotatorów



Ból może występować w okolicy barku, górnej części ramienia i łopatki.

Staw barkowy jest bardzo elastycznym stawem kulistym, utworzonym przez trzy kości: łopatkę, kość ramienną i obojczyk. Cztery mięśnie stożka rotatorów są kluczową częścią tego, co zapewnia stabilność barku. Uszkodzenie któregośkolwiek z tych mięśni wpływa zatem na funkcjonowanie stawu.

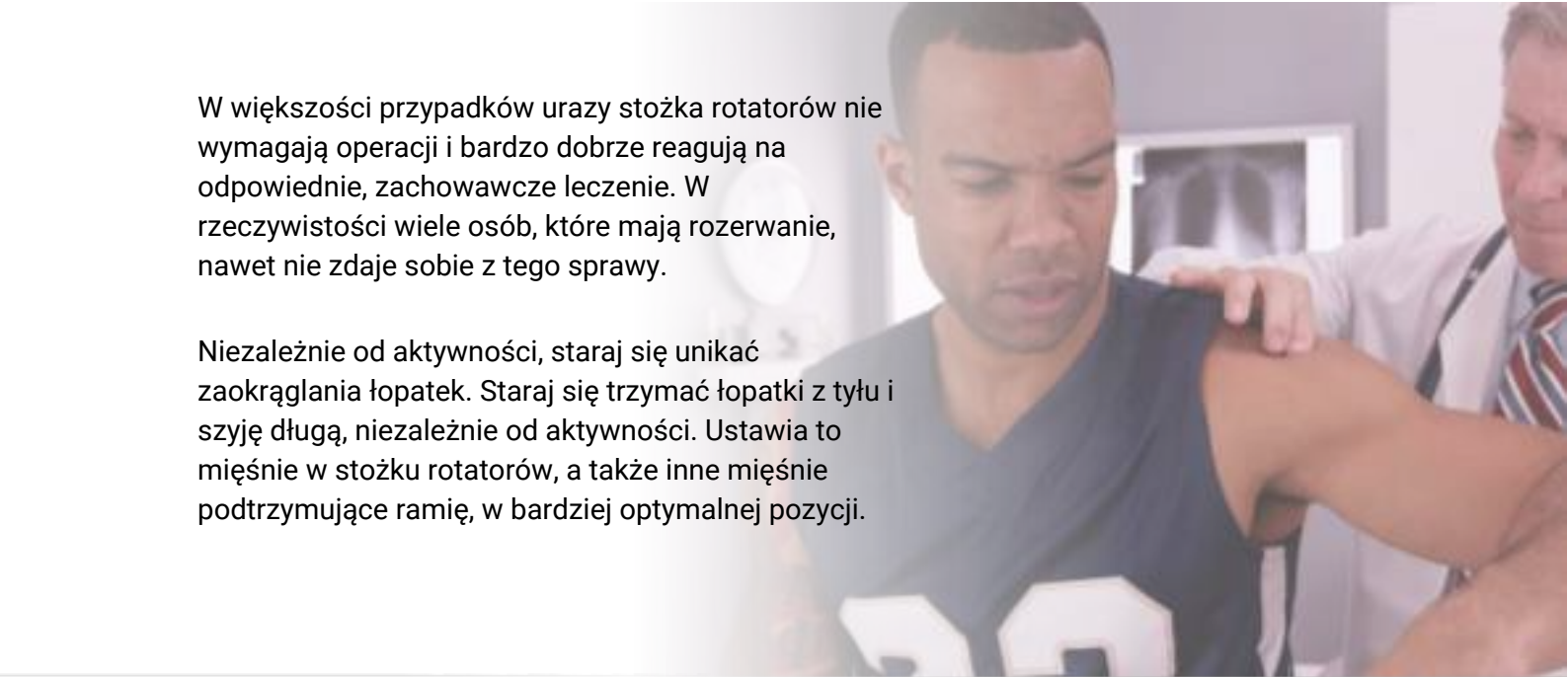
Zazwyczaj urazy stożka rotatorów są częstsze wraz z wiekiem. Złe ustawienie i/lub powtarzające się używanie może prowadzić do kumulatywnego obciążenia tych mięśni. W rezultacie mogą one ulec podrażnieniu, a nawet rozerwaniu.

Nagły uraz, na przykład niefortunny upadek, może spowodować podobne uszkodzenia.



W większości przypadków urazy stożka rotatorów nie wymagają operacji i bardzo dobrze reagują na odpowiednie, zachowawcze leczenie. W rzeczywistości wiele osób, które mają rozerwanie, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.

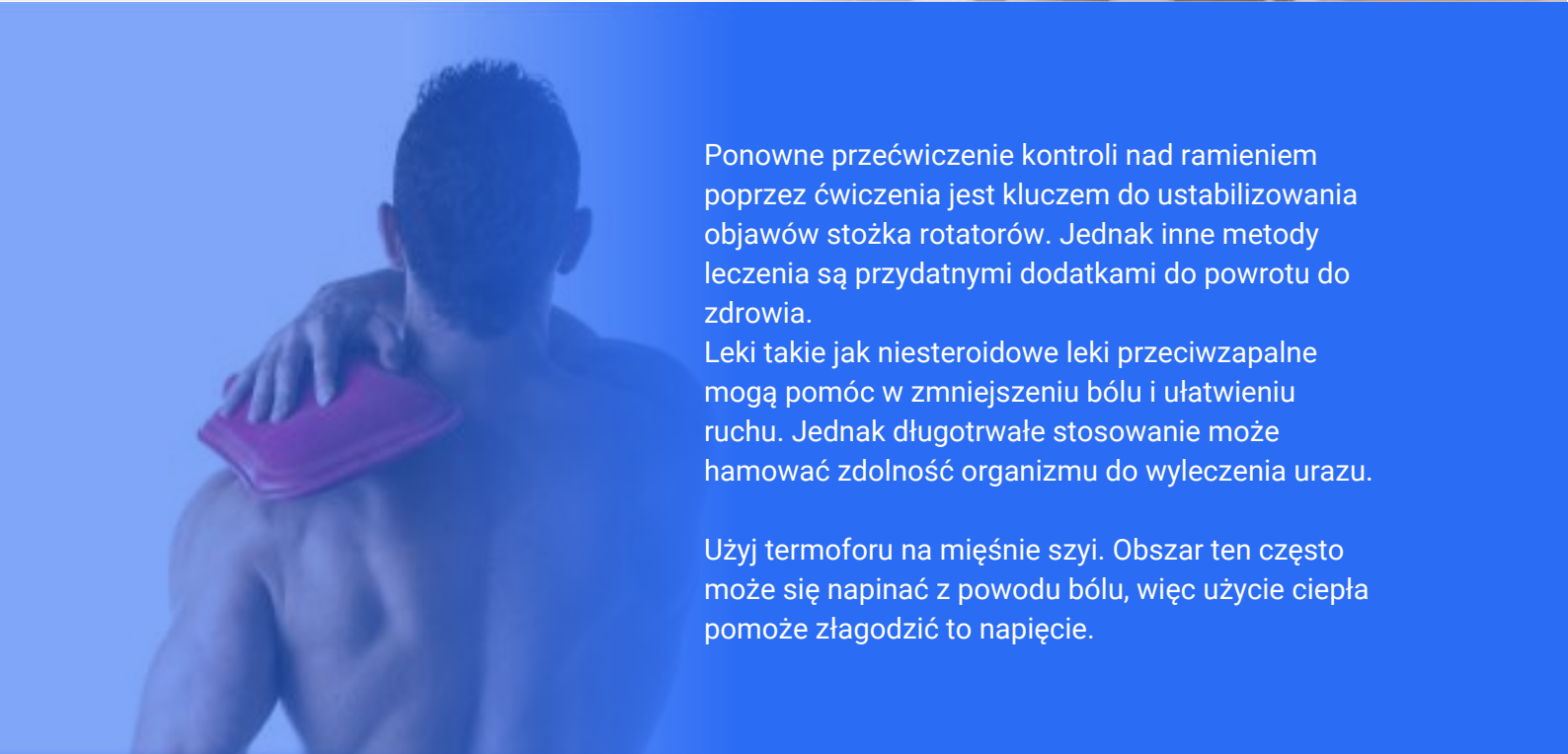
Niezależnie od aktywności, staraj się unikać zaokrąglania łopatek. Staraj się trzymać łopatki z tyłu i szyję długą, niezależnie od aktywności. Ustawia to mięśnie w stożku rotatorów, a także inne mięśnie podtrzymujące ramię, w bardziej optymalnej pozycji.



Ponowne przeciwiczenie kontroli nad ramieniem poprzez ćwiczenia jest kluczem do ustabilizowania objawów stożka rotatorów. Jednak inne metody leczenia są przydatnymi dodatkami do powrotu do zdrowia.

Leki takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą pomóc w zmniejszeniu bólu i ułatwieniu ruchu. Jednak długotrwałe stosowanie może hamować zdolność organizmu do wyleczenia urazu.

Użyj termoforu na mięśnie szyi. Obszar ten często może się napinać z powodu bólu, więc użycie ciepła pomoże złagodzić to napięcie.

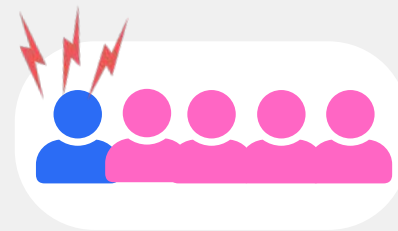


Ważne jest, aby przyrzeć się czynnościom, które wywołały u Ciebie ból. Monitoruj swoją postawę, przejrzyj technikę i rób przerwy, jeśli to konieczne, aby zapobiec dalszemu zaostrzaniu objawów.

Rozciąganie pomaga zapobiegać sztywności barku, nie narażając się na zbyt duże ryzyko zaostrzenia objawów. Ćwiczenia wzmacniające powinny koncentrować się na mięśniach posturalnych, a także na stożku rotatorów. To skoryguje każdą słabą koordynację mięśniową, która przyczyniła się do powstania kontuzji.

Twój fizjoterapeuta poprowadzi Cię przez proces ćwiczeń w tempie dostosowanym do Twojego stanu zdrowia.

Okolo **1 na 5 dorosłych** doświadczy bólu barku w pewnym momencie swojego życia, a prawdopodobieństwo to wzrasta wraz z wiekiem. Ból związany z mankietem rotatorów (RCRP) jest najczęstszym rodzajem bólu barku doświadczanym przez dorosłych.



W przeszłości RCRP określano mianem „ucisku” i termin ten jest czasami używany do dziś. Jednak „ucisk” może być mylącym terminem, ponieważ sugeruje, że ból jest bezpośrednią konsekwencją czegoś „zaczepiającego” lub „szczypiącego” wewnątrz barku podczas ruchu. Chociaż może to odpowiadać subiektywnemu odczuciu osoby odczuwającej ból barku, wiemy, że strukturalne ustalenia prowadzące do diagnozy „ucisku” są równie powszechne u dorosłych z bólem barku i bez niego. Oznacza to, że badania obrazowe, takie jak skany MRI i USG, nie zawsze mogą przekonująco powiedzieć nam, skąd pochodzi ból barku. W świetle tego ustalenia, takie jak ostrogi kostne, ogólny stan zapalny i uszkodzenia stożka rotatorów, można często uznać za normalne „wiek-
„związane z aktywnością” zmiany w barku i niekoniecznie muszą być „naprawione”, aby złagodzić ból.

Czym jest stożek rotatorów (Rcrp)?

RCRP to termin ogólny, który może odnosić się do mięśni, ścięgien i otaczających je struktur barku, takich jak kaletki maziowe, kości, więzadła, torebki stawowe, nerwy i tkanki naczyniowe. Osoby z RCRP często odczuwają ból i osłabienie, gdy ramię jest odsuwane od ciała (np. podczas sięgania w górę) lub gdy kładą rękę za plecami. Ból może pojawiać się powoli z czasem lub dość szybko, jeśli ramię było używane w sposób, do którego nie jest przyzwyczajone lub do którego nie jest uwarunkowane. Terapia ruchowa i samoleczenie są pierwszą linią leczenia RCRP.

Ćwiczenia i RCRP

Nie ma podejścia „uniwersalnego”, jeśli chodzi o stosowanie ćwiczeń w leczeniu RCRP i żaden konkretny program ćwiczeń nie wykazał wyższości nad innym. Jednak aby ćwiczenia były skuteczne, muszą być ustrukturyzowane i dostosowane do Ciebie. Z tego powodu nie każda osoba otrzyma ten sam program rehabilitacyjny, a wszelkie przepisane ćwiczenia będą oparte na dokładnej indywidualnej ocenie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę.





Plan działania

1

Precyzyjna diagnoza

Na początku przeprowadzamy dokładną diagnostykę, aby określić, czy problem ma charakter strukturalny (np. uszkodzenie mięśni, stawów czy ścięgien), czy funkcjonalny (gdzie wyniki badań obrazowych są prawidłowe, a przyczyną jest ochrona generowana przez układ nerwowy).

Redukcja stanu zapalnego

Jeśli jest to konieczne, redukuję stan zapalny za pomocą odpowiednich metod, takich jak terapia światłem czerwonym, zmiany w stylu życia czy wsparcie żywieniowe.

2

3

Odczulanie i leczenie (metoda PDTR)

Kluczowym etapem pracy jest odczulanie układu nerwowego za pomocą **metody PDTR**. Polega to na odnalezieniu obszarów przeciążeń lub dawnych urazów oraz „zresetowaniu” sygnałów receptorowych. Dzięki temu eliminuję błędne odpowiedzi układu nerwowego, które powodują ból, ograniczenia ruchu i nadmierną ochronę mięśni i stawów.

Przywracanie pełnej ruchomości

Następnie uczę pacjenta, jak uzyskać pełną kontrolę nad zakresem ruchu w każdej osi i płaszczyźnie. Poprawiam elastyczność i zakres ruchu, aby przywrócić pełną funkcję stawu ramennego.

4

5

Wzmocnienie i ochrona

Na końcu skupiam się na wzmocnieniu osłabionych obszarów, aby zapobiec nawrotom problemu. Celem jest „odporność” na przyszłe przeciążenia i urazy.

Ty i Twój terapeuta możecie wybrać ćwiczenia, które skupiają się na jednym lub wszystkich z następujących obszarów: siła, kontrola, stabilność i „szybsze” ruchy reaktywne. Wcześniej prowokujące aktywności mogą być również modyfikowane, aby można je było wykonywać w sposób bardziej akceptowalny dla Ciebie. Pomaga to uniknąć niepotrzebnego odzwyczajania się, które występuje, gdy ktoś unika ruchu i wykonywania czynności wywołujących ból. Modyfikacja aktywności powinna pozwolić Ci powrócić do cenionych aktywności lub kontynuować w nich udział.



Wskazówka dotycząca ćwiczeń!

Jeśli Twój lekarz zalecił Ci ćwiczenia wzmacniające barki, które wymagają dużego wysiłku lub „zmęczenia”, zaleca się, abyś pomiędzy tymi sesjami ćwiczeń odczekał 24 godziny, aby ścięgna stożka rotatorów miały czas na regenerację.

Czynniki związane ze stylem życia i RCRP

Prawdopodobieństwo wystąpienia RCRP jest większe, jeśli palisz, masz nadwagę i przechodzisz zmiany hormonalne, takie jak menopauza lub perimenopauza.

Siedzący tryb życia i zły sen mogą również negatywnie wpływać na Twój ból. Z tego powodu Twój terapeuta może poświęcić czas na omówienie tych czynników z Tobą i poszukać sposobów na zajęcie się wszelkimi modyfikowalnymi czynnikami stylu życia, takimi jak Twoja aktywność fizyczna, które mogą mieć wpływ na Twój powrót do zdrowia.

Aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają osobom dorosłym następujący poziom aktywności fizycznej w tygodniu:

- Aktywność fizyczna aerobowa:
 - 150 do 300 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności lub 75–150 minut ćwiczeń o dużej intensywności lub kombinacja ćwiczeń o dużej i umiarkowanej intensywności.
- Ćwiczenia wzmacniające:
 - dla wszystkich głównych grup mięśni; ze średnią lub dużą intensywnością; 2 lub więcej dni w tygodniu.

WHO zaleca również:

- skrócenie czasu spędzanego w bezruchu; zwiększenie czasu spędzanego na aktywności o dowolnej intensywności (np. korzystanie ze schodów zamiast windy); wykonywanie ćwiczeń aerobowych i/lub wzmacniających częściej niż
- jest to zalecane w celu uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych.

Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać
dostęp do
odnośników do
artykułów:

